EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	:	87732
SERVICIO	:	MEDICINA HSC			
FECHA	:	2024-07-02 11:38:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: PEDRO FLORENCIO QUEZADA GODOY			RUN	: 6.109.150-5
F.Nac	: 01-12-1948	Edad	: 75 AÑOS, 7 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: V MACKENNA 892			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-06-04	Fecha Egreso	: 2024-07-02 11:38:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I50.0-INSUFICIENCIA CARD?ACA CONGESTIVA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. PCR -> AESP 4/6/24
2. ICC descompensada en EPA / resuelto
3. Cardiopatía dilatada FEVI 30%
4. Portador de Resincro-DAI
5. FA en TACO
6. ERC estadio IV
7. HTA
8. TRAQUEOBRONQUITIS AFNIA ALVEI

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I50.0-INSUFICIENCIA CARD?ACA CONGESTIVA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

TRASLADO DESDE UPC
CONSULTA 4.6.24 POR CUADRO DE ABRUPTA TAQUIARRITMIA, DISNEA, DETERIORO HEMODINAMICO. EN S.U. PCR CON AESP -> RCP 4 CICLOS. SE MANEJA EN UPC/UCI/UTI -> VM, DVA, TERPIA AB EMPIRICA. SE REALIZA VALORACION DAI/R QUE CONCLUYE EPISODIOS FA CON RV RAPIDA, RECONOCIDAS COMO FV.TV CON TERAPIAS INAPROPIADAS -> SE SUGIERE AMD, BB, ABLACION NODO AV TRAS ESTABILIZACION CLINICA GLOBAL
***
EN SALA BASICA VIGIL, DESORIENTADO, CONTENIDO. AFEBRIL, HEMODINAMIA ESTABLE. ALGO ENFALQUECIDO.
CON TRASTORNO DEGLUTORIO DE EVOLUCION FLUCTUANTE, SE NUTRE POR SNG. SIN POSIBILIDAD DE VALORACION POR OTRRINO HASTA PROXIMA SEMANA.
DADO ESTABILIDAD CLINICA SE DECIDE CONTINUAR MANEJO EN FORMATO DE HOSPITALIZACION DOMICILIARIA
ADJUNTAR EPICRISIS TRASLADO UPC

PLAN DE MANEJO:

*
PLAN
HOPITALIZACION DOMICILIARIA
REHABILITACION MULTIPROFESIONAL / KINE-FONO
AJUSTO DOSIS NEOSINTROM PARA INR 2-3, control inr 5.7.24
P VALORACION DEGLUCION POR OTORRINO
CONTROL AL ALTA CARDIOLOGIA

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo en cama- Movilizar por KNT/cabecera 30-45°
2. Régimen glucerna a 70cc/hr por SNG + agua por SNG a 40ml/hr
3. FiO2 para Sat 90%
4. Kine R y M , mas manejo de secresiones (aspiracion)
5. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via OFTALMICA
6. ATORVASTATINA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
7. FLUTICASONA/SALMETEROL INHALADOR 250 MICROGRAMOS / 25 MICROGRAMOS 2 inhalador cada 12 hrs. por 30 dias via INHALATORIA
8. AMIODARONA COMPRIMIDO 200 MILIGRAMOS 0.5 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
9. BISOPROLOL COMPRIMIDO 2,5 MILIGRAMOS 2 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
10. FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 3 dias via ORAL
11. ACENOCUMAROL COMPRIMIDO 4 MILIGRAMOS LU-MI-VI = 1/2 MA-JU-SA-DO = 1/4
12. EMPAGLIFLOZINA 10MG COMPRIMIDO UNIDAD 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
13. HALOPERIDOL COMPRIMIDO 1 MILIGRAMO 0.5 comprimido cada 8 hrs. por 30 dias via ORAL

EXÁMENES Y RESULTADOS

EXS 26.6.24 CREA 1.4, PCR 51, BUN 77, HB 14, GB 14000, PLT 321000
EXS 1.7.24 CREA 1.6, PCR 38, NA 137, K 4.0
EXS 2.7.24 INR 1.9
ULTIMA TAC TORAX 18.6.24 -> NEUMONIA LOB IZQ, CARDIOMEGALIA
ULTIMO TAC CEREBRO 18.6.24 SIN HALLAZGOS DE CARACTER AGUDO, CAMBIOS INVOLUTIVOS ENCEFALICOS ESPERABLES PARA LA EDAD, ATEROMATOSIS VASOS INTRACRANEANOS

OBSERVACIONES:

ADJUNTAR EPICRISIS TRASLADO UPC

CALDERON SOLIS CRISTIAN JOSE
MEDICO TRATANTE
15161784-0

JEFE SERVICIO